

التميّز التشغيلي · من الدراسات العلمية

يحلّ الموظف المشكلة بنفسه، فتعود إليه في اليوم التالي.

وفي 93% من الحالات لم يعلم بها أحد.

راقبت باحثتان طواقم التمريض في تسعة مستشفيات أمريكية، فوجدتا أن الإخلاص في العمل قد يكون هو نفسه ما يمنع المؤسسة من التعلّم.

← اسحب للمتابعة

الدراسة

ما الذي رأته الباحثتان؟

أمضت الباحثتان أنيتا تاكر وإيمي إدموندسون 239 ساعة تراقبان عمل 26 ممرضًا وممرضة في تسعة مستشفيات أمريكية، اختير أكثرها لأنه معروف بجودة التمريض.

ورصدتا خلال ذلك 194 خللًا في العمل اليومي، أغلبها مشكلات مألوفة: دواء لم يصل، أو جهاز معطّل، أو مستلزمات نفدت، أو وجبة عادية قُدّمت لمريض سكري.

لم تكن مشكلات معقدة، ولم يكن حلّها يحتاج إلى خبرة نادرة.

مثال من الدراسة

حلٌّ يُنهي الموقف، وحلٌّ يُنهي المشكلة

نفدت الأغطية النظيفة في نوبة ليلية، فأخذت الممرضة ما تحتاج إليه من قسم آخر وأكملت عملها. انتهى الموقف، لكن شيئًا لم يمنع تكرار المشكلة في الليلة التالية.

والحل الآخر أن تُكمل عملها، ثم تُبلغ القسم المسؤول عن الأغطية أو مديرها، حتى يُعالَج السبب.

تسمّي الدراسة الأول First-order problem solving، أي معالجة المشكلة في لحظتها، والثاني Second-order problem solving، أي معالجة سببها حتى لا تتكرر.

Tucker & Edmondson, CMR, 2003

النتائج

أُغلب المشكلات عولجت في لحظتها، ثم نُسيت

93%

من المشكلات اكتفى فيها الطاقم بما يُمكّنه من إكمال العمل، دون أن يُبلغ أحدًا.

7%

فقط من الحالات نُبِّه فيها من يملك إصلاح السبب، مع أن الباحثتين لم تتشددا في الحكم.

33

دقيقة تضيع في المتوسط من كل نوبة مدتها ثماني ساعات، في معالجة أعطال كان يمكن التخلص منها.

Tucker & Edmondson, CMR, 2003

ولم يكن السبب تقصيرًا

الممرضون كانوا يبذلون أكثر مما يُطلب منهم

تسعة من كل عشرة ممرضين راقبتهم الباحثتان طوال النوبة بقوا بعد انتهائها 45 دقيقة في المتوسط، بلا أجر إضافي، ليُكملوا رعاية مرضاهم.

وقال سبعة من تسعة ممن قابلتهم الباحثتان إنهم يشعرون بالرضا حين يجدون طريقة يتجاوزون بها العائق.

وهنا المفارقة: كلما نجح الموظف في التعامل مع المشكلة وحده، بقيت مخفية عمّن يستطيع إصلاحها.

Tucker & Edmondson, CMR, 2003

لماذا لا تتعلّم المؤسسة؟

ثلاث ممارسات حسنة في ظاهرها، تعطّل التعلّم في الواقع

1

يُربّى الممرضون على أن يتحمّل كلٌّ منهم مسؤولية ما يواجهه ويحلّه بنفسه، فيعالج كلٌّ موقفه، ولا يتغيّر النظام.

2

ويُحسب عدد الطاقم بحيث يكفي للعمل بالكاد، فلا يبقى وقت لتتبّع أسباب المشكلات.

3

ومنحُ الفريق استقلاليته أبعد المديرين عن الميدان، فبقي الممرضون وحدهم أمام مشكلات مصدرها أقسام أخرى.

وقال 70% ممن قابلتهم الباحثتان إن مديريهم ينتظرون منهم أن يتدبّروا هذه العوائق وحدهم.

ما الذي يستطيع القائد فعله؟

1

أن يحضر إلى موقع العمل في كل نوبة ولو وقتًا قصيرًا، فتصله المشكلات الصغيرة قبل أن تتراكم.

2

أن يجعل الإبلاغ عن المشكلة أمرًا آمنًا، لا يُفهم منه أن صاحبه عاجز عن عمله.

3

أن يستجيب لكل بلاغ بإجراء يراه الفريق؛ فالناس يكفّون عن الإبلاغ حين يرون أن أحدًا لا يُصغي.

> كم مشكلة حلّها فريقك اليوم بنفسه، وستعود إليه غدًا؟

حدود هذه الدراسة

اعتمدت على الملاحظة والمقابلات، ولم تكن تجربة تقارن بين مجموعتين.

شملت 26 ممرضًا وممرضة في مستشفيات أمريكية، ونُشرت عام 2003، فلا تمثّل كل المستشفيات ولا كل القطاعات.

تخصّ نسبها المشكلات التي شهدتها الباحثتان أثناء المراقبة فقط.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Tucker, A. L., & Edmondson, A. C. (2003). Why Hospitals Don't Learn from Failures: Organizational and Psychological Dynamics That Inhibit System Change. *California Management Review*, 45(2), 55–72.